末梢血液塗抹標本における破砕赤血球の報告が人工血管再置換術の契機になった 1 症例

◎安藤 穂乃実[1)]、石田 真理子[1)]、坪井 由佳里[1)]、牛丸 明香理[1)]、加藤 洋平[1)]、上野 嘉彦[1)]、岡 有希[1)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院[1)]

【はじめに】破砕赤血球は、播種性血管内凝固（DIC）や血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）、人工弁置換術後などの機械的溶血で認められることが知られている。今回、末梢血液塗抹標本での破砕赤血球確認を契機に、人工血管再置換術につながった 1 例を経験したので報告する。

【症例】50 歳代男性。X 年 12 月、突然の背部痛を主訴に当院へ救急搬送された。造影 CT 検査にて上行から腹部大動脈に及ぶ急性大動脈解離を認め、上行弓部大動脈置換術が施行された。術後経過は良好であったが、第 12 病日に Hb 6.8 g/dL と高度貧血を認めた。赤血球輸血後も改善乏しく、当院血液・感染症内科にて原因精査が行われた。

【検査結果】WBC 5.57×10³/μL、RBC 3.16×10⁶/μL、Hb 9.4 g/dL(輸血後)、MCV 94.9 fL、PLT 281×10³/μL、Reti 8.78％、AST 52 U/L、LD 1733 U/L。末梢血液塗抹標本にて破砕赤血球を認めた。尿定性検査では蛋白（1+）、潜血（2+）、尿沈渣では赤血球<1 / HPF、尿細管上皮細胞 20-29 / HPF、硝子円柱 100-999 / WF、上皮円柱 30-99 / WF を認めた。

【経過】破砕赤血球の出現より機械的溶血が疑われたが、血小板減少は認めなかった。人工血管置換術後であるため、精査目的として心エコー図検査が施行された。左室駆出率 64％と心機能は良好であったが、吻合部人工血管内に乱流を認め、造影 CT 検査にて、フェルトの翻転による人工血管狭窄が確認された。溶血性貧血進行による多臓器不全が危惧され、第 29 病日に人工血管再置換術が施行された。

【考察】破砕赤血球は DIC、TTP や人工弁関連溶血で認められることが知られるが、人工血管狭窄による機械的溶血は稀である。本合併症が発生すると重篤な転帰をたどる可能性があり、早期診断が望ましい。今回、末梢血液塗抹標本での破砕赤血球確認を契機に原因検索が行われ、人工血管狭窄の診断および再手術につながった。この経験から、心臓血管手術後に破砕赤血球を認めた際には、生理検査部門と速やかに情報共有を行うことが重要と考えられた。

【結語】心臓血管手術後に破砕赤血球を認めた場合、人工血管狭窄による機械的溶血を念頭に置く必要がある。末梢血液塗抹標本の観察と部門間連携は、早期対応および重篤化回避に有用と考えられた。

(連絡先：058-230-7253)